



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : علا عبد الفتاح محمد مديولي

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : مصر القديمه العنوان : مصر القديمه

رقم البطاقة : 28303100104405 رقم التليفون : 01113176343 تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 10-03-1983 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولاديكس قسم العلاج : الاورام [14165]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: علا عبد الفتاح محمد مديول National ID: 28303T00104405	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

تأشيرة خروج من مصر الى الخارج
بطاقة تحقيق الشخصية

علا

عبد الفتاح محمد مديوني

٨ ش حسن الانور من سيدى حسن الانور

مصر القديمة - القاهرة

٢ ٨٣ ٠٣ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٤ ٤ ٠ ٥

٧٧٢٦١٣٤٤٦



٢٠٢٣/٠١

٢٨٣٠٣١٠٠١٠٤٤٠٥

رنة شزل

مسترجعة

القنى

محمدة ياسين احمد النينا

٢٠٢٣/٠١/٠٢ حتى

١



٧

Patient Name : الأستاذة / علا عبدالفتاح محمد مديوني
Patient No. : 28303100104405
Path No. : 1522/2022
Sex : Female
Age : 39 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13007593
Request Date : 02/06/2022
Verification Date : 15/06/2022
Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Left breast mass.

Nature of the specimen:
Tru cut biopsy, collected at 2/6/2022, 01:41 PM.

Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II (3+2+1)
- IPT :
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (Allred score 8/8)
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)
- Her-2: Weak incomplete membrane reaction in tumor cells (score 1+)
- Ki 67: 15 % nuclear reaction

Diagnosis:

- Left breast mass, Tru cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, grade II
 - ER : Positive (8/8)
 - PR : Positive (8/8)
 - HER2 : Negative (score 1+)
 - Ki 67: 15 % nuclear reaction

Verified by :
DR. Israa Elgendy



Printing Date : 23/06/2022 09:00:44

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Name: علا عبد الفتاح محمد مدبولي		
MR. : 4393		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was diagnosed with a premenopausal left-breast invasive ductal carcinoma, grade 3, estrogen receptor-positive (8/8), progesterone receptor-positive (8/8), and HER2-negative. Neoadjuvant chemotherapy was administered consisting of docetaxel (Taxotere) ×4 cycles followed by an anthracycline-cyclophosphamide regimen (AC) ×4 cycles. After completion of neoadjuvant therapy, the patient underwent a mastectomy in January 2023. Post-operative management included radiation therapy and endocrine therapy with an aromatase inhibitor (Arimidex) and a luteinizing hormone-releasing hormone agonist (Zoladex). The current plan continues hormonal suppression with Zoladex and Arimidex.		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	الطبيب المعالج :	Doctor2
يعتمد ,		

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name الأستاذة / علا عبدالفتاح محمد مديوني
Patient No. 28303100104405
Path No. 1522/2022
Sex Female
Age 39 Y
Referring Doc.
Request No. 13007593
Request Date 02/06/2022
Verification Date 15/06/2022
Financial Category برامج دار السلام - نفقة الدولة
Department Out Patient
Registered by marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Dr. Israa Eigendy

Prof. Dr. Aml Hareedy
Dr. Walaa Ghonaim

Verified by :
DR. Israa Elgendy

Printing Date : 23/06/2022 09:00:44

Page 2 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse



Patient Name: Ola Abd Al Fattah Mohamed Madboli	Date : 25/06/2022
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 39 Year(s)
Medical ID: left breast cancer for metastatic workup	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

- Left breast irregular speculated mass lesion measuring 5 X 2.5 cm.
- Prominent subcentimetric left axillary lymph nodes.
- No pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous low CT attenuation. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Few prominent subcentimetric right iliac mesenteric lymph nodes.

3. The scanned skeleton:

Patient Name: Ola Abd Al Fattah Mohamed Madboli	Date : 25/06/2022
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 39 Year(s)
Medical ID: left breast cancer for metastatic workup	

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- *No definite pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.*

Dr. Ahmed Ekbal, MSc.

Dr. Amr Farouk, M.D.



Patient Name: Ola Abd Al Fattah Mohamed Madboli	Date : 29/08/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 2394/2022	Pat. ID: 14135

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MPM1 with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Asmaa Zenhom

29/08/2024 1:19 PM



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Wellness

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والرفاهية



MDT form

A- Patient ID:

1- Name: علا محمد مديوني

Sex:

3- Medical number:

Female

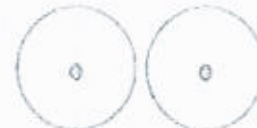
83082205

Old Med:

2394/2022

2-ID number: 28303100104405

Patient Age: 48 Y



Family history: -VE

Phone:

01113176343

BMI:

REASON OF MDT:

POST-OPERATIVE

marital status: MARRIED

NRS Score:

GROUP:

B

Date of MDT:

02/19/2023 05

Comorbidity: DM

Menopausal status:

POSTMENOPAUSAL

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

CTCAP6/22-->FREE,, BONE SCAN-->FREE

BX:

ER:

PR:

Her 2 Neu:

SISH:

Ki67:

IDC

8/8

8/8

0

15

LT GII 6/22

T

3

N

0

M

0

Sonomammography

LT BREAST MULTICENTERIC MALIGNANT MASS BIRADS 5

PATIENT HISTORY

PATHOLOGY REPORT 24/1/2023-->LT SM AND LT SLN BIOPSY POST NACT (4 AC+ 4 TAXOTERE)

IDC GII,,FREE NIPPLE AND AREOLA,,FREE DEEP MARGIN,,+VE METASTATIC DEPOSIT IN ONE SLN 1/5
WITH NO EXTRACAPSULAR INVASION,,PPR,, STAGE YPT2 YPN1

MDT OUTCOME & PLAN

For AI and Zoladex
PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

02/19/23

RADIOLOGY

02/19/23

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition